

GALS Aide-mémoire :

Anamnèse :

- Douleur/raideur articulation, muscle, colonne
- Habillage
- Escalier

Marche (3 pas et retour) :

- Symétrie,
- Fluidité, ballant bras,
- Bassin équilibré,
- Longueur pas, phase de marche,
- Stabilité au demi-tour

Rachis a) de dos

- Symétrie masse musculaire (trapèzes, deltoïdes, scapulaires, paravertébraux, fessiers)
- Equilibre : épaules, crêtes iliaques
- Creux poplité (tuméfaction, kyste)
- Tendon d'Achilles.

b) latéral

- Courbures-équilibre global
- Flexion antérieur dorso-lombaire
- Inclinaison cervicale

Membres supérieurs (debout)

- Mains derrière la tête (mobilité articulaire épaules et coudes en flexion)
- Extension coude
- Dos des mains (déformation, tuméfaction)
- Paumes (=pro-supination, coloration, tuméfaction, trophicité, etc.)
- Poings (flexion doigts)
- Motricité fine
- Etreinte (détection synovite)

Membres inférieurs a) debout

- Alignement général, varus/valgus genoux,
- Déformations orteils,
- Voutes plantaires

b) couché

Trophicité quadriceps

- Tuméfaction genoux
- Déformation avant-pieds
- Talon fesse main sur le genou (crépitations)
- Poursuivre pour flexion de hanche
- Retour à 90° pour Rotations hanches interne / externe
- Palpation genou (chaleur, épanchement)
- Etreinte MTP
- Callosité.

Skills locomoteurs B3.8

Support d'apprentissage pour le test de GALS

Le GALS est un test de dépistage pour les pathologies de l'appareil locomoteur. Il comprend une partie d'anamnèse et une partie d'examen physique.

L'anamnèse comprend 3 questions :

1. Avez-vous des douleurs ou des raideurs dans les articulations, muscles ou dans le dos ?
2. Pouvez-vous vous habiller complètement vous même sans aucune difficulté ?
3. Pouvez-vous monter et descendre les escaliers sans aucune difficulté ?

GALS est un acronyme pour **G**ait (marche), **A**rms (membres supérieurs), **L**egs (membres inférieurs) et **S**pine (colonne vertébrale). Pour rappel, l'examen physique s'effectue avec le patient en sous-vêtements.

<u>Nom du test ou de la manœuvre</u> Signification de la positivité	<u>Description</u> a. Position et action du patient b. Action de l'examineur c. Pièges techniques et astuces	<u>Photos ou illustration</u>
Marche Causes de marche pathologique possible : arthrose ou arthrite des articulations : sacro-iliaque, hanche, genou, pied ; insuffisance du tendon moyen fessier ; atteinte inflammatoire ou mécanique de la colonne vertébrale lombaire; atteinte neurologique centrale (p.ex. accident vasculaire cérébral) ou périphérique (p.ex. hernie discale lombaire avec radiculalgie)	a. Le patient marche quelques pas et se retourne rapidement b. On juge de la symétrie et fluidité des mouvements des membres sup. et inf. et du bassin, de la longueur des pas, du déroulement du pied et de la capacité du patient de tourner rapidement	
Colonne vertébrale – aspect dorsale Peut montrer une scoliose, une bascule du bassin ou de la ceinture scapulaire, une asymétrie de la musculature du tronc et des membres inf. Une tuméfaction poplitée peut se rencontrer en cas de kyste poplitée (dit « de Baker »). L'inspection du pied peut montrer des déformation (p.ex. en varus/valgus) ou des tuméfactions articulaires (p.ex. en cas d'arthrite ou arthrose décompensée)	a. Patient debout, le dos vers l'examineur b. On juge de la forme de la colonne dans le plan frontal; de la musculature para vertébrale, des épaules et de la région fessière; le niveau des épaules et des crêtes iliaques, les fosses poplitées et la forme et position de l'arrière-pied c. Pendant l'examen, le niveau des épaules et du bassin peut varier en fonction de la position des	

	membres inf. P.ex., si le patient fait une flexion antalgique d'un genou ou a un appui plus important sur un des membres inf., il faut lui demander de s'appuyer de manière symétrique sur ses jambes.	
Colonne vertébrale - aspect latérale On peut constater de troubles statiques, comme une hyperlordose ou une hypercyphose, ainsi qu'une diminution de la mobilité normale de la colonne lombaire, comme en cas de lombalgie aigue ou de spondylarthrite ankylosante (une maladie inflammatoire qui peut provoquer une ankylose de la colonne vertébrale)	a. Patient debout, de profil, statique, puis on laisse le patient faire une flexion (« touchez vos pieds ») b. Inspection : on évalue les lordoses cervicale et lombaire et la cyphose dorsale. On évalue la mobilité de la colonne lombaire de la manière suivante: on met un doigt approximativement sur L1 et autre doigt de la même main approximativement sur L5 (par exemple l'index/le pouce et le petit doigt, respectivement) en position debout et on laisse le patient effectuer une flexion de la colonne, tout en gardant nos doigts en place. La distance entre nos doigts doit augmenter entre la position neutre et la flexion du tronc (de 4-5 cm habituellement). c. Il faut bien garder les doigts en place en regard de épineux de L1 et L5 pendant la flexion. En laissant le patient se pencher en avant, on mesure également (indirectement) la flexion des hanches.	
Inspection de face – colonne vertébrale Une diminution de la mobilité de la colonne cervicale peut se rencontrer p.ex. en cas d'arthrose facettaire, en cas d'arthrite atlanto-axoïdienne (polyarthrite rhumatoïde, chondrocalcinose), mais également en cas de contracture de la musculature cervicale.	a. Patient debout ; il est demandé de toucher les épaules avec sa tête. b. On évalue la latéroflexion de la colonne cervicale c. Le patient ne doit pas surélever les épaules pendant cette manœuvre	

Inspection de face – membres sup.

1. Mobilité incomplète p.ex. en cas d'arthrite /arthrose /épaule gelée.

Patient debout.

- 1.a. On lui demande de mettre les mains derrière la tête.
- 1.b. On observe la mobilité de l'articulation gleno-humérale, acromio-claviculaire et sterno-claviculaire, ainsi que la flexion des coudes.



2. Une mobilité diminuée peut être constatée p.ex. en cas d'arthrite/arthrose du coude

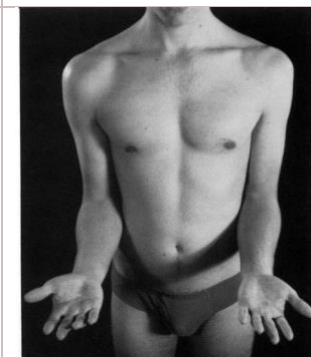
- 2.a. On demande au patient de tendre les bras le long du corps.
- 2.b. On observe l'extension des coudes.

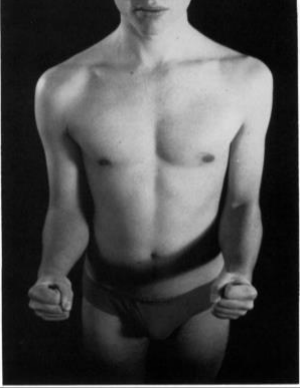
3. Des tuméfactions articulaires peuvent être constatées en cas de maladie inflammatoire (p.ex. des articulations MCP et IPP dans la polyarthrite rhumatoïde) ou dégénérative (IPP et IPD dans l'arthrose digitale)

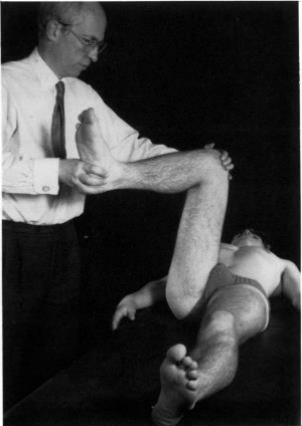
- 3.a. On demande au patient de montrer ses mains, la face dorsale vers le haut, doigts tendus.
- 3.b. On évalue la peau, la musculature, les éventuelles tuméfactions articulaires et l'extension des doigts, la pronation.

4. Idem

- 4.a. On demande au patient de tourner ses mains.
- 4.b. On évalue la peau, la musculature, les éventuelles tuméfactions articulaires, la supination.



5. Causes de diminution de la force de préhension : arthrite, arthrose, ténosynovite	5.a. On demande au patient de serrer les poings ; on demande au patient de nous serrer 2 doigts. 5.b. On évalue la force de préhension.	
6. Mouvements difficiles/incomplets en cas de problème articulaire, déficit neurologique ou problème tendineux	6.a. On demande au patient de toucher le bout du pouce avec chaque doigt long. 6.b. On évalue la motricité fine	
7. Douleurs en cas d'arthrite des MCP. L'arthrose des MCP est rare et elle est toujours secondaire (p.ex. suite à une arthrite ou à un traumatisme).	7.b. On serre la main du patient en amont des articulations MCP ddc	
Inspection de face – membres inf. Il peut y avoir des atrophies musculaires, des tuméfactions articulaires (en cas d'arthrose/arthrite), des déviations de l'axe du genou (varus/valgus), des troubles statiques du pied (avant-pied adductus/abductus, pied plat/creux etc)	a. Patient debout. b. On inspecte la musculature, les axes, les articulations (genoux, pieds), l'avant-pied, le mi-pied, les voûtes plantaires.	

Membres inf. en décubitus dorsale 1. Mobilité réduite si arthrose/arthrite	1.a. Le patient est allongé sur le lit d'examen 1.b. On effectue une flexion du genou et de la hanche lors du même mouvement. On revient avec le genou en flexion à 90°, hanche fléchie à 90° et on effectue une rotation interne de la hanche (le pied pivote vers l'extérieur), en gardant la cuisse dans l'axe verticale.	
2. Épanchement articulaire possible en cas d'arthrite/arthrose/tumeur	2.b. On effectue une pression vers le bas sur la rotule avec l'index d'une des mains après avoir « ramené » l'éventuel liquide synoviale du récessus suprapatellaire derrière la rotule avec l'autre main.	
3. Manœuvre douloureuse en cas d'arthrite/arthrose/névrome de Morton ou bursite intercapitométatarsienne	3.b. On serre l'avant pied en amont des articulations MTP	
4. Les callosités anormales indiquent la présence d'une surcharge mécanique à cet endroit (p.ex. des callosités en regard des MTP 2 et 3 indiquent un affaissement de la voûte plantaire transversale avec appui pathologique sur les têtes des métatarsiens 2 et 3)	4.b. On inspecte la peau de la plante des pieds.	